

Fecha Última Actualización: 30-07-2022 17:22:15

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Ruth Jenoveva Díaz Gamboa

Rut : 5.577.857-4

N° Archivo : 0916346

N° Epicrisis
316983

Edad : 74a 6m 25d

Fecha Nacto: 05/01/1948

Sexo : Femenino

Dirección : Laguna Del Inca 4039, Villa Andes Del Su

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 9 6253 8297

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 03/07/2022 17:14

Días Estadía : 27

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 30/07/2022 17:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Paro cardiorespiratorio

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES ***Datos extraídos de Ficha Electrónica
Médicos: DM2 NIR, HTA, ICC, ACxFA, Tabaquismo detenido
Alergias: no
Social: Autovalente

HISTORIA ACTUAL

Traída el 03/07 a Servicio de Urgencia HSR el por SAMU, tras PCR en domicilio, familiar realiza maniobras de BLS, a la llegada de SAMU paciente en AESP, reaniman por 20min, 4 ciclos, 4 mg de adrenalina, 500ml SF, instalación TOT intraparo a 22cm en comisura labial. SV FC 113lpm, PA 60/43, Sat O2 98% FIO2 100%, HGT 216, FR 15, sale a ACxFA

Ecoscopia: VD/VI relación conservada, contractilidad VI alterada, leve derrame pericárdico, sin líneas B, vena cava calibre conservado, aorta abdominal sin alteración, sin líquido libre intraabdominal.

Requiere inicio de DVA NAD + Adrenalina

Se interrogó a hija, refiere que paciente presentaba síntomas de ICC hace varios meses, previo al ingreso con dolor ambos hombros y dorso, síntomas vasovagales, episodio de disnea y cianosis, luego compromiso de conciencia, llaman a SAMU quienes indican iniciar BLS y llegan a los 3 minutos.

Se rescató PCR COVID positivo 03/07

Evaluada por UCO, antecedente EcoTT 02/2021 y EcoTE 12/2021 con dilatación biauricular severa, hipertrofia concéntrica de VI con FEVI preservada, trombo intracavitario OI. Además SPECT/SESTA-MIBI-DIPYRIDAMOL del 04/2022 sin signos de isquemia.

Ahora con ECG FA BCRD T negativa V4 a V6, se realizó ecoscopia HVI severa septum 16mm, cavidad ventricular muy pequeña con colapso de paredes en sístole, sin valvulopatías evidentes, cavidades derechas normal, sin derrame pericárdico, dilatación severa biauricular (más grande que ventrículos). Se sospechó miocardiopatía hipertrófica o cardiopatía infiltrativa, se sugiere volemicización y TAC Aorta, estudio coronariográfico invasivo y CardioRMN una vez estable.

Se realizó TAC cerebro sin lesiones agudas, AngioTAC TAP, 1. Intubación monobronquial, con extremo distal en el bronquio intermedio. 2. Examen negativo para síndrome aórtico agudo y negativo para tromboembolismo pulmonar central. 3. Los hallazgos descritos en ambos riñones, glándulas suprarrenales y asas de yeyuno son compatibles con "complejo de hipoperfusión" (o intestino de shock). 4. Coledocolitias múltiple obstructiva. 5. Acentuada cardiomegalia. Ateromatosis aórtica y coronaria difusa.

Se traslada a UPC para continuar manejo.

Fecha Epicrisis : 30/07/2022 17:22

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 30-07-2022 17:22:15

Página 2 de 3

Al ingreso sedada Fentanyl/Midazolam, en VMI AC/V, NAD 0.5gama Adrenalina 0.1gama

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

- 1.Shock cardiogénico, PCR recuperado
 - a.Sospecha taquiarritmia ventricular
 - b.Sospecha miocardiopatía hipertrófica vs cardiopatía infiltrativa
 - c.Intestino de shock
- 2.ACxFA RVR
- 3.Insuficiencia renal aguda
- 4.PCR COVID positiva 03/07
- 5.Coledocolitiasis múltiple obstructiva
- 6.Antecedentes: DM2 NIR, HTA, ICC, ACxFA, Tabaquismo detenido

EVOLUCIÓN EN UCI

Hemodinámico: Se inició al ingreso BIC Amiodarona para favorecer precarga. Logra suspender inotropos, evolucionando hipertensa, requiere inicio de VDO, que posteriormente se suspenden

Con amiodarona por FA con RVR, se inició anticoagulación plena con Enoxaparina.

Amiodarona y Anticoagulación suspendidas en contexto de pronóstico neurológico de paciente.

Cardiológico: Evaluada por UCO, antecedente EcoTT 02/2021 y EcoTE 12/2021 con dilatación biauricular severa, hipertrofia concéntrica de VI con FEVI preservada, trombo intracavitario OI.

Ecoscopia de ingreso: HVI severa septum 16mm, cavidad ventricular muy pequeña con colapso de paredes en sístole, sin valvulopatías evidentes, cavidades derechas normal, sin derrame pericárdico, dilatación severa biauricular (más grande que ventrículos). Se sospechó MCH o cardiopatía infiltrativa, se sugiere TAC Aorta, estudio coronariográfico invasivo y CardioRMN una vez estable.

Ventilatorio: Intubada el 03/07 en reanimación por PCR.

AngioTAC Tx del 03/07: Sin Sd Aórtico, sin TEP.

Conectada a VMI protectora CPAP, sin conflicto de intercambio, logra retirarse apoyo de Ventilador, permanece en Tubo T.

Infeccioso: Con sospecha de Neumonía aspirativa por SAMS y E. coli MS. Completó 7 días de Cefazolina.

El 28/07 evolucionó febril, dado pronóstico neurológico, acordado por jefaturas, no se realiza estudio ni inicio de antibióticos.

Neurológico: Cursa con compromiso de conciencia, sin sedación desde el 07/07, persiste en coma.

En seguimiento por Neurología, se interpreta como Encefalopatía hipóxico-isquémica con elementos clínicos de mal pronóstico neurológico (patrón motor).

Último EEG 10/07 en Status epiléptico. Se ajustó Levetiracetam a 2g cada 12h.

TAC de cerebro 08/07: lesiones isquémicas subagudas (cerebelosa y frontal derecha y occipital izquierda). Se describe como lluvia embólica.

EEG control 14/07, persiste actividad epiléptica, se indica inicio de Ac. Valproico, luego se agregó Diazepam y Fenitoina por control EEG con actividad epiléptica persistente. Con niveles de Fenitoina y Ac. Valproico subterapéuticos, EEG 21/07 frecuente AE interictal bifrontal, DLCO, se suspende Fenitoina por ser perpetuador de mioclonías y además por antecedentes cardíacos de la paciente, se ajustó dosis de Ac. Valproico y dado mal pronóstico funcional, se define no realizar más EEG, sólo seguimiento clínico para ajuste de FAE.

Renal: sin conflicto actual.

Definido por Jefaturas, manejo proporcional, no DVA, no RCP

Inicia dificultad respiratoria el 27/07 sin requerimientos de oxígeno suplementario, por lo que se inicia BIC de Morfina, posteriormente taquicardica, hipotensa, desaturación hasta 80% y febril, se da aviso a familia.

DIAGNÓSTICOS

- 1.Compromiso de conciencia
 - a.SENC
 - b.Obs Encefalopatía hipóxico-isquémica
- 2.PCR recuperado, ROSC 20 minutos, obs Taquiarritmia ventricular
- 3.Shock cardiogénico recuperado
 - a.Sospecha miocardiopatía hipertrófica vs cardiopatía infiltrativa
- 4.ACxFA
- 5.Neumonía aspirativa tratada

Fecha Epicrisis : 30/07/2022 17:22

Página 2 de 3

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 30-07-2022 17:22:15

Página 3 de 3

- 6. Insuficiencia renal aguda recuperada
- 7. PCR COVID positiva 03/07
- 8. Coledocolitiasis múltiple obstructiva
- 9. Antecedentes: DM2 NIR, HTA, ICC, ACxFA, Tabaquismo detenido

Paciente evoluciona con bradicardia extrema posterior asistolia, se constata obito el día 30/07/2022.
Se da aviso a familia.

Diagnóstico de Egreso

Paro cardiorespiratorio recuperado - Encefalopatía hipoxico isquémica

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecido

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Andrea Betina Vaquera
Médico Tratante (Staff)